UNIVIDA

Cartilha de Primeiros Socorros

2020



Proteção à primeira infância: ensinando a socorrer

AÇÃO UNIVIDA
1998
UNIVERSIDADE DE ALFENAS - MG

UNIFENAS

Autores coordenadores:
Betina Rodrigues Kroneis
Bruna Maria Vieira Silva
Gabrielli Naiara Vieira Miranda
Gabryela Queiroz de Souza
Giovani Caiolli Noel Scapin Santos
Isabella Miranda Esteves Orsi
Lanna Antunes de Faria Lima
Maria Clara de Souza Dias Noronha
Miguel Neri Beraldo da Silva
Rubens da Silva Rios
Tayná Rodrigues Félix
Tiago Gonzaga

Autores:
Allef Moreira Carvalho
Ana Carolina Moreira Silva Maciel
Ana Elisa Molina David
Andrezza do Carmo Camargo
Beatriz Mano Guimarães
Betina Rodrigues Kroneis
Bruna Cardoso Souza
Bruna Maria Vieira Silva
Bruna Souza Miranda Barros
Carolina da Cruz Lopes
Caroline Alves Paschini
Danillo Ziegler Dias
Diêgo Thomaz Silveira
Eduardo Faria Prado
Eliza Freitas Leite
Gabrielli Naiara Vieira Miranda
Gabryela Queiroz de Souza
Giovani Caiolli Noel Scapin Santos
GiulliaNovack Ferreira Rocha
Gustavo Lourenço Migliori Campos
Gustavo Oliveira Silva
Heitor de Oliveira Gouveia
Helenna Maria da Silveira Ribeiro
Isabella Miranda Esteves Orsi
Isadora Martins Garcia
Isadora Oliveira Banhos
João Paulo Lopes Jordão
João Vitor Cardoso Moraes
Joyce Aline Rocha dos Santos
Júlia Oliveira Moreira
Karoliny de Sousa Martins
Laís Dias Berbert
Lanna Antunes de Faria Lima
Larissa Carvalho Oliveira
Larissa Terra Freire
Laura Ballassoni Terra
Léo Pedro Rufino
Leonardo Luca Luciano
Leonardo Vieira Munhoz
Lívia AmpessanIácono
Lívia Santos Vilela
Luana Lopes Alves
Luciano Barbosa Morgan de Aguiar
Luiza Barbosa Brito
Luíza Bruzadelli Franco de Carvalho
Marcela Facci Andrade
Maria Clara de Souza Dias Noronha
Miguel Neri Beraldo da Silva
Mônica Riças Figueiredo
Murilo Campos Silva
Pedro Henrique Pires Abrantes
Pedro Victor Castilho Costa
Rafaelly Carolina Ferreira
Rebeca Andrade Gomez Mojon
Rubens da Silva Rios
Tayná Rodrigues Félix
Tiago Gonzaga
Yasmin Teixeira Nunes

Abreviações

EPI	Equipamento de proteção individual
RCP	Ressuscitação cardiopulmonar
DEA	Desfibrilador externo automático
Obs	Observação
PAS	Pressão arterial sistólica

Agradecimentos

Esta cartilha de primeiros socorros voltada aos professores de ensino básico foi criada por acadêmicos da área da saúde, seus professores e colaboradores, membros do projeto “Proteção à primeira infância: ensinando a socorrer”. Este trabalho tem como objetivo nortear o atendimento perante situações de risco para as crianças, assim como permitir que os funcionários ofereçam o melhor atendimento, em caso de emergências, diminuindo assim possíveis danos maiores e aumentando as chances de sobrevida.

Agradecemos aos professores coordenadores do projeto Dr. Robson Eugênio Silva e Dr. Wilson Gonçalves da Silva Júnior, por todo conhecimento passado e pelas orientações, tanto para elaboração do projeto quanto para esta cartilha.

Agradecemos a toda equipe da Diretoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UNIFENAS, em especial o Professor Rogério Ramos de Prado, que nos incentivou e nos ajudou na montagem desta cartilha.

Introdução

O ambiente escolar é cenário importante de incidentes que demandam primeiros socorros, uma vez que é um local de oportunidade para que as crianças, através de corridas, esportes, brincadeiras diversas e curiosidade pelo desconhecido, estejam susceptíveis a pequenos traumas exigindo cuidados que não podem ser subestimados. Porém, quando se trata desse assunto observa-se que o tema é pouco trabalhado, assim é de suma importância abordar este assunto dentro do âmbito escolar, frente à possibilidade de que pequenos acidentes do dia a dia, como um engasgamento, podem resultar na ocorrência de um óbito.

Como promotores desses cuidados estão os professores e demais funcionários ali presentes, muitas vezes em tempo integral. Sendo assim, essas pessoas além de educadores, tornam-se os primeiros a prestar cuidados de primeiros socorros até a chegada de uma equipe de atendimento pré-hospitalar.

Nesse intuito, nós, participantes do projeto “Proteção à primeira infância: ensinando a socorrer”, criamos essa cartilha explicativa sobre primeiros socorros, voltada para funcionários de escolas de ensino básico, desde professores a demais funcionários.

PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Quando suspeitar:

- Paciente não responde ao estímulo;
- Com respiração agônica ou ausente;
- Com pulsação carotídea palpável (parada respiratória) ou ausente (parada cardiorrespiratória).

O que fazer:

Realizar avaliação primaria (VC VIU):

V = verificar segurança do local, verificar resposta da vítima (tocar os ombros e chamar o paciente em voz alta) e verificar a presença de respiração;

C = chamar o socorro e pedir o DEA (desfibrilador externo automático); Socorro 192 (SAMU) ou 193 (BOMBEIROS);

V = verificar pulso carotídeo por até 10 segundos;

I = iniciar compressões (30 compressões x duas insuflações por cinco ciclos);

U = utilizar o DEA.

*insuflação é a mesma coisa que ventilação. Ela deve ser feita após abertura da via aérea da vítima e com o ar que o socorrista tem nos pulmões, sem forçar a saída de ar. A imagem abaixo mostra como deve ser feita a abertura de via aérea.





Figura 3 - Manobra da inclinação da cabeça e elevação do queixo. *Figura 4* - Manobra de elevação do ângulo da mandíbula.

Quando parar: Quando a vítima apresentar um desses sinais: tosse, respiração ou movimentação.

Cuidados durante a manobra:

- Comprimir/pressionar o tórax em pelo menos cinco cm (sem exceder seis cm);
- Permitir o completo retorno do tórax após cada compressão;

- Não se apoiar sobre o tórax após cada compressão.

Cuidados pós-parada cardiorrespiratória:

- Manter o DEA no tórax do Paciente; não retirar as pás;
- Avaliar sinais vitais.

Obs.:

1. Parada Respiratória = 1 insuflação a cada 6 segundos → verificar pulso a cada 2 minutos.
2. Parada Cardiorrespiratória = 30 compressões x duas insuflações → reavaliar sinais a cada 2 minutos.



Figura 2 - Posicionamento para realização das compressões torácicas.

CONVULSÕES

Definição: desordem nas atividades eletrofisiológicas cerebrais promovendo movimentos involuntários pela vítima, bem como contrações e relaxamentos intensos e descontrolados dos músculos.

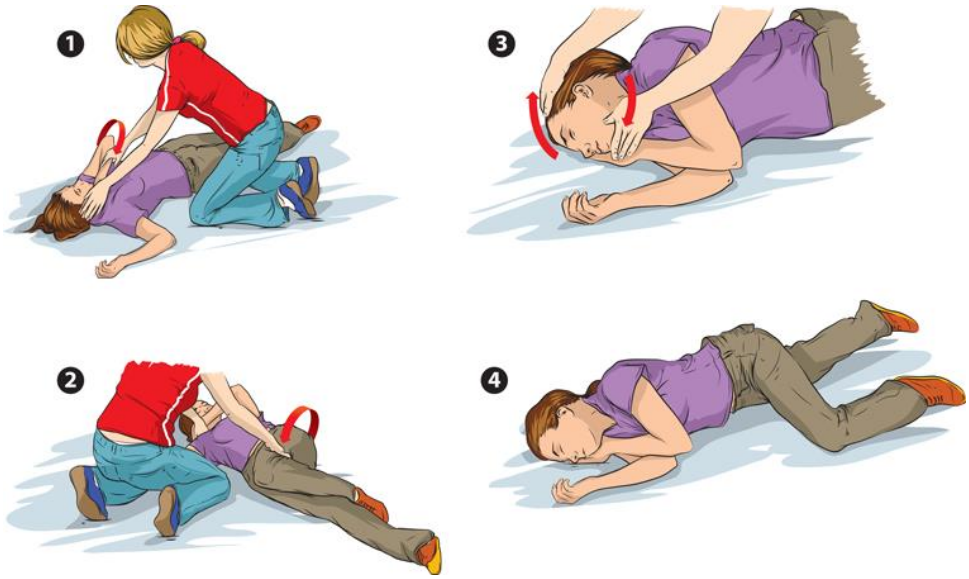
Causas: febre alta; hipoglicemia (diminuição dos níveis de açúcar no sangue); desidratação; traumas; perda excessiva de sangue; intoxicações por álcool, medicamentos ou drogas; sinais luminosos e sonoros.

O que fazer:

- Manter a calma;
- Amparar a vítima antes da queda;
- Afastar curiosos;
- Proteger cabeça e membros;
- Afastar objetos cortantes;
- Afrouxar as roupas;
- Cronometrar a crise;
- Realizar avaliação primária (VCVIU).

O que fazer após a crise: acalmar a vítima; colocar a vítima lateralizada para o lado **esquerdo**; providenciar atendimento médico.

O que não fazer: não use força para contê-la; não coloque nada em sua boca (dedo, objetos); não ofereça água, alimentos ou medicação durante a crise; não jogar água no rosto da vítima; não tentar “desenrolar” a língua da vítima.



HEMORRAGIA

Definição: saída de sangue dos vasos sanguíneos. Pode ser venosa, arterial ou capilar.

O que fazer:

1. Realizar Avaliação Secundária (VCVIU) e utilizar EPI (equipamento de proteção individual);

2. Identificar o local do sangramento;

3. Comunicar a vítima sobre o procedimento e expor a ferida (cortar as roupas);

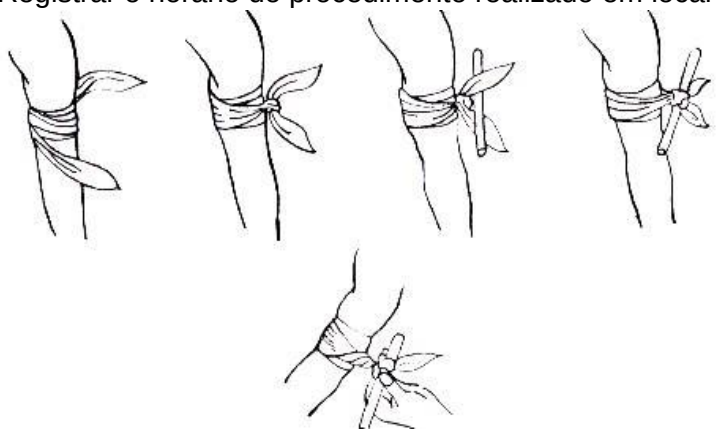
5. Aplicar gazes ou compressa estéril diretamente sobre o ferimento;

6. Aplicar compressão manual direta sobre o ferimento (a pressão deve ser mantida até que o sangramento pare);

7. Realizar curativo compressivo e não se esquecer de sempre verificar pulso e perfusão capilar (aperte a ponta dos dedos, e verifique se volta a corar em menos de 2 segundos).

Se o sangramento não parar o que fazer:

- Compressão direta ou indireta do local;
- Fazer o uso de torniquete:
  1. 5 cm acima do local da lesão;
  2. Pegar uma faixa de aproximadamente 10 cm de largura;
  3. Amarre a faixa duas vezes ao redor da extremidade lesada
  4. Dê um nó firme;
  5. Coloque um bastão sobre o nó e amarre novamente;
  6. Dê outro nó firme;
  7. Utilize o bastão como uma manivela para rodar e apertar a faixa;
  8. Aperte o torniquete até o sangramento parar;
  9. Mantenha o torniquete firme;
  10. Registrar o horário do procedimento realizado em local visível na vítima.



Obs.: Não remover a primeira atadura que foi colocada sob a hemorragia, se encharcar aplicar um novo curativo sobre o primeiro exercendo maior pressão manual. - Não remover objetos encravados.

CHOQUE

Quando suspeitar:

Temperatura da pele	Fria, úmida, pegajosa
Coloração pele	Pálida ou cianótica
Pressão arterial	Diminuída (PAS < 90 mmHg)
Nível de consciência	Alterado
Enchimento capilar	> 2 segundos
Frequência cardíaca	Aumentada (> 100 bpm)
Frequência respiratória	Alterada (< 8 ou > 28 mrm)

O que fazer:

- Realizar avaliação primária periodicamente (VCVIU) e tentar identificar a causa do choque;
- Previna a perda de calor, mantendo a vítima aquecida, com uma manta térmica ou cobertor;
- Remover roupas molhadas se for o caso.

INTOXICAÇÃO E ENVENAMENTO

Definição intoxicação: substância causadora está visível; o efeito é o esperado; geralmente por substâncias químicas.

Definição envenenamento: contato sem ver; o efeito é inesperado; geralmente por toxinas animais.

Quando suspeitar: Confusão mental; falta de ar; quando no local forem identificados substâncias ou objetos que podem ser os causadores em contato direto ou próximo da vítima.

O que fazer:

- Entrar em locais confinados ou com atmosfera suspeita somente com uso de EPI's;
- Solicite atendimento especializado;
- Tentar identificar o tipo de agente causador, observar o local;
- Remover o acidentado para um local bem ventilado;
- Realizar avaliação primária (VCVIU);
- Mantenha a vítima aquecida e sempre amparada.

O que não fazer: boca-a-boca em dúvida se foi ingerido ou inalado; induzir o vômito; não dar nenhum tipo de alimento ou água; não deixar a vítima sozinha; entrar em locais confinados sem o uso de EPI´s.

QUEIMADURAS

Quando suspeitar: na presença de lesões dos tecidos (pele) em decorrência de trauma de origem térmica ou química, resultante da exposição ou contato com chamas, líquidos, superfícies quentes ou produtos químicos.

Classificação das queimaduras de acordo com a profundidade e sinais:

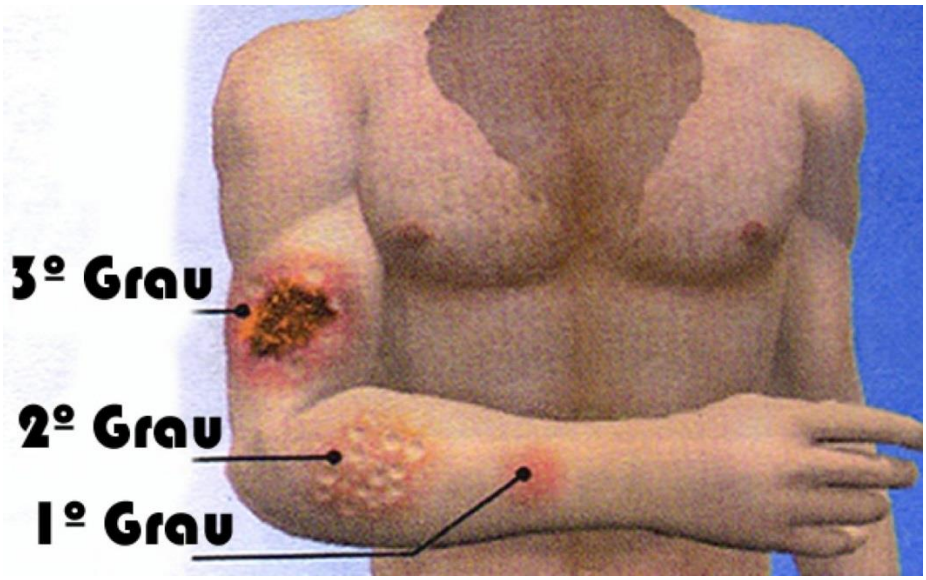
- 1º Grau: Lesões apenas da epiderme: presença de eritema (vermelhidão).
- 2º Grau: Lesões da epiderme e parte da derme: presença de eritema + bolha.
- 3º Grau: Lesões da epiderme e da derme: presença de pele branca (nacarada) ou enegrecida (escura/ preta).

O que fazer:

1. Afastar o paciente do agente causador ou o agente do paciente;
2. Realizar avaliação primária (VCVIU);
3. Observar o aspecto geral da face do paciente: cílios, sobrancelhas, pelos do nariz e condições respiratórias, para informar ao socorro;
4. Expor a área queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas;
5. Retirar objetos como anéis, aliança, brincos, pulseiras, relógio, carteira, cinto, desde que não estejam aderidos à pele;
6. Irrigar com soro fisiológico em abundância, resfriando a área queimada; em seguida cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes;
7. Prevenir a hipotermia (perda de calor), preferencialmente com manta metálica;
8. Passar os dados de forma completa aos socorristas.

O que não fazer: não passar qualquer tipo de pomada, pasta de dente, leite, entre outros; não romper ou perfurar as bolhas.

Obs.: se o agente causador for substâncias químicas como Soda Cáustica ou Cal Virgem, como medidas de Primeiros Socorros: retirar o excesso da substância (com pano limpo); não irrigar com soro fisiológico ou água.



FRATURAS, ENTORSES E LUXAÇÕES

Como identificar:

- FRATURA é a quebra da continuidade do osso. A fratura pode ser fechada – quando não houve rompimento da pele, ou seja, o osso não aparece; ou pode ser exposta – sempre que o osso aparecer a partir do rompimento da pele.
- ENTORSE é uma lesão dos ligamentos de uma articulação, sem que ocorra o deslocamento das superfícies articulares, conhecido também como torção. Ocorrem normalmente nos joelhos e tornozelos.
- LUXAÇÃO é o desencaixe de um osso de sua articulação, associada à luxação pode ocorrer a ruptura de ligamentos.

O que fazer:

Fratura fechada:

1. Se possível imobilize o membro com uma madeira ou um papelão, prendendo com panos ou similares, evitando assim aumentar o risco de lesões internas;
2. Encaminhe a vítima para atendimento médico/hospitalar.

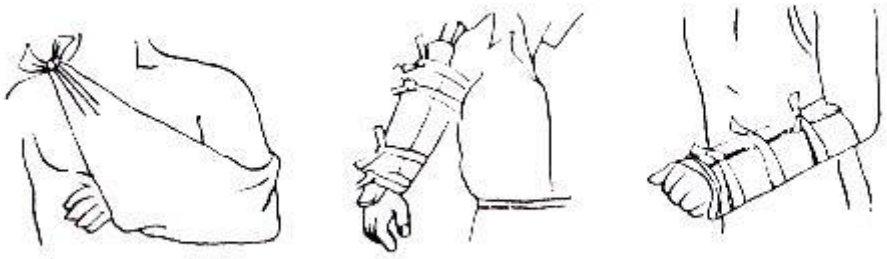
Fratura exposta:

Vítima consciente:

1. Verifique se há hemorragia, se houver faça pressão no vaso com pano limpo ou gaze; nunca troque o primeiro pano limpo ou gaze colocada, apenas acrescente;
2. Se possível imobilize o membro afetado com madeira, papelão ou com o que for mais estável possível, fixe a tala com panos (nunca fixar sobre o local afetado) – sem apertar muito. Lembre-se de sempre respeitar a posição em que o osso foi encontrado (posição anatômica), ou seja, NUNCA MEXA NO OSSO;
3. Proteja o local em que o osso estiver exposto com um pano limpo;
4. Encaminhe a vítima para atendimento médico/hospitalar.

Vítima inconsciente:

1. Chame a Ambulância – SAMU (ligue 192);
2. Lembre-se de delegar funções: solicite que alguém ligue para ambulância, enquanto você verifica pulso e respiração.
3. Verifique pulso e respiração, na ausência destes inicie a RCP;
4. Se houver hemorragia pressione o vaso com um pano limpo, mas nunca mexa no osso;
5. Continue as manobras de reanimação até retornarem os movimentos respiratórios e batimentos cardíacos ou até a chegada da ambulância para transporte e atendimento da vítima.



O que não fazer:

1. Procure não movimentar o membro afetado;
2. NUNCA ofereça nenhum tipo de líquido ou alimento a vítima;

Em caso de entorse ou luxação: Para alivio da dor pode aplicar gelo no local.

ENGASGAMENTO

Definição: - Engasgamento é a obstrução das vias aéreas superiores por um corpo estranho. Em adultos geralmente ocorre por conta de alimentos sólidos. Já em bebês tanto por alimentos líquidos quanto por pequenos objetos.

Quando suspeitar: Se a pessoa estiver consciente ela tentará falar, mas não conseguirá, não consegue respirar ou tossir, vítima estará cianótica e agitada, gestos universais de sufocação.



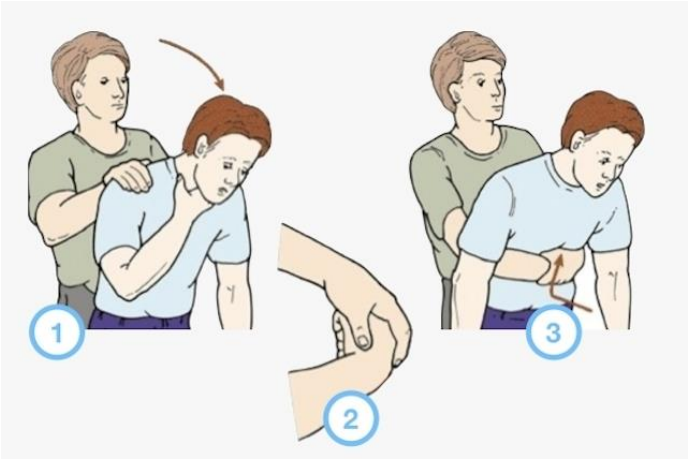
O que fazer:

Adulto ou criança consciente:

1. Verificar se a pessoa pode falar ou tossir;
2. Orienta-la a tossir;
3. Verificar presença de sons respiratórios incomuns;
4. Verificar presença de cianose.
5. Realizar manobra de Heimlich

Técnica da Manobra de Heimlich:

1. Abraçar a pessoa engasgada pelo abdômen;
2. No caso de adultos, posicionar-se atrás da pessoa ainda consciente;
3. No caso de crianças, posicionar-se atrás, mas de joelhos;
4. Atrás da vítima coloque uma das mãos sobre a região da “boca do estômago” e com a outra mão, comprima a primeira mão, ao mesmo tempo em que empurra a região dentro e para cima, parecendo que está levantando a pessoa;
5. Continue o movimento até que a pessoa elimine o objeto que está causando a obstrução.



Pessoa inconsciente, não realize a manobra e contate imediatamente o serviço de emergência.

Bebê consciente:

1. Coloque o bebê de bruços em cima de seu braço e faça cinco compressões entre as escápulas (no meio das costas);
2. Depois, vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões sobre o esterno (osso entre os mamilos);
3. Se conseguir visualizar o objeto, retire o mesmo;
4. Caso não seja possível a visualização do objeto, nem a retirada, continue realizando as compressões até a chegada do serviço de emergência.



AFOGAMENTO

Definição: afogamento é a dificuldade respiratória por aspiração de um liquido.

O que fazer: O afogado está desesperado e busca de todas as maneiras algo que flutue.

1. Realize uma abordagem verbal.
2. Tente entregar algo que flutue para vítima, evitando entrar na água.
3. Evite, ao máximo, ter que entrar sozinho na água.

4. Entrar na água com o mínimo de roupa possível.
5. Induzi-la a ficar de costas para você.
6. **Agarrar a vítima por trás**: mão dominante livre para o nado.

Essa abordagem pode ser feita de duas formas:

Reboque pelo queixo

→ Rebocar a vítima pelo queixo posiciona-la na horizontal e face fora da água.



Figura 3: reboque pelo queixo

Reboque peito cruzado

→ Rebocar a vítima abraçando o peito é a maneira mais favorável para afogados tomados de pânico.



Figura 4: reboque peito cruzado

CURATIVOS

Qual a finalidade:

- Proteger a ferida de microrganismos, promovendo a cicatrização sem contaminação;
- Controlar sangramentos;
- Absorver secreções.

Primeiro passo:

1. Higienização das mãos e autoproteção com luvas;
2. Limpar ferimento com soro fisiológico ou água com grande frequência;
3. Proteger o ferimento com gaze e/ou ataduras.

Observação: caso o curativo sair ou movimentar, jamais deve substituí-lo. Realize novos curativos por cima do danificado.

Tipos de curativos:

1) Curativo compressivo: colocar gaze sobre o ferimento; cubra a gaze com algodões para que, caso sangre ou saia secreções, seja possível a absorção; prenda o curativo com esparadrapo ou passe atadura para que mantenha o ferimento comprimido.
2) Curativo 3 pontas: cobrir ferimento com plástico; prender esparadrapos apenas em 3 dos 4 lados do curativo; manter o

lado sem curativo a favor da gravidade, propiciando a saída de secreções líquidas.

3) Curativo ocular: cobrir olho ferido com copo descartável; fixar copo descartável com esparadrapos e atadura ao redor da cabeça; outros procedimentos: colocar gaze sobre e fixar com esparadrapos, a fim de evitar movimentos e possível agravamento da lesão.
4) Curativo em eviscerações: cobrir ferimento com pano e/ou gazes molhados em soro fisiológico; sobre o pano, colocar plástico ou papel alumínio para manter a temperatura e higienização.
5) Curativo em objetos transfixados: imobilizar objetos transfixados com gaze, ataduras e esparadrapos; a imobilização não deve passar sobre o objeto, apenas ao redor; a única exceção em que deve retirar o objeto transpassado é em obstrução de vias aéreas e em casos de impedimento de realização de manobra de RCP.
6) Curativo na cabeça: em casos de hemorragia, colocar gazes cobrindo o ferimento; utiliza-se duas ataduras, uma vai dar a volta horizontalmente e a outra verticalmente, dando voltas ao redor da primeira; as voltas com ataduras não devem passar sobre as orelhas e olhos.

Conclusão

O período da primeira infância é de grandes oportunidades para a plenitude da vida de uma pessoa, é também de muitas vulnerabilidades, estando aqui a importância da capacitação dos profissionais que vivem ao redor dessas crianças. Portanto, a criança também tem o direito de ter ao seu redor pessoas capacitadas a ajudá-la, principalmente no contexto dos primeiros socorros, já que a capacitação se torna uma profilaxia para situações de perigo e consequências negativas. Nesse sentido, esta cartilha tem a função de instruir os professores e funcionários das escolas de ensino básico, para que possam dar um suporte adequado em situações de risco, salvando vidas.

Referências Bibliográficas

ATKINS, Dianne L. et al. Part 11: pediatricbasiclifesupportandcardiopulmonaryresuscitationquality: 2015 American Heart Associationguidelinesupdate for cardiopulmonaryresuscitationandemergency cardiovascular care. Circulation, v. 132, n. 18_suppl_2, p. S519-S525, 2015

GONZALEZ, MM et al . I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. **Arq. Bras. Cardiol.**, São Paulo , v. 101, n. 2, supl. 3, p. 1-221, Aug. 2013 . Availablefrom<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2013003600001&lng=en&nrm=iso>. accesson 21 Oct. 2020. https://doi.org/10.5935/abc.2013S006.